

Stranieri e sicurezza sociale + LAMal

— Schema

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 09

Numeri chiave — Svizzera paese d'immigrazione

- **9,1 mio** abitanti totali → **2,4 mio** stranieri residenti permanenti → **1 su 4** non è svizzero
 - **73%** immigrazione 2025 da UE/AELS · motivazione principale: lavoro
 - Fonte: [Ufficio federale di statistica 2025](#)
-

Tensione strutturale

- **Inclusione economica** → stranieri lavorano, versano contributi, pagano imposte
 - **vs. inclusione giuridica condizionata** → accesso ai diritti dipende da permesso, soggiorno, nazionalità, contributi, reddito
 - [Welfare protegge dai rischi MA entra in tensione con politica migratoria](#)
-

Evoluzione storica

Periodo	Evento / Logica
XIX sec.	Welfare locale → stranieri esclusi, dipendono da beneficenza privata
Industrializzazione	Bisogno manodopera straniera + paura Überfremdung (inforestierimento)
1931	Nasce statuto stagionale: "lavoratori sì, cittadini no"

Periodo	Evento / Logica
1962	Conv. Svizzera-Italia → prima esportazione rendite
2002	Accordo libera circolazione Svizzera-UE → coordinamento sicurezza sociale
Oggi	Libera circ. non = welfare universale; legame permesso-autonomia economica resta

Statuto stagionale (1931–2002)

- Permesso legato a contratto specifico → no mobilità lavorativa
- **Nessun ricongiungimento familiare**
- Nessun accesso assistenza sociale
- Viveva in condizioni precarie
- Pagava contributi (AVS, AI, IPG, infortuni) ma diritti limitati

I tre criteri dei diritti sociali degli stranieri

- **Contribuzione** → ha lavorato e versato? → AVS, AI, disoccupazione, 2° pilastro
- **Residenza** → vive stabilmente con quale statuto? → LAMal, aiuto sociale, prestazioni cantonali
- **Statuto** → tipo di permesso → tabella sotto

Permessi e accesso prestazioni

Permesso	Accesso	Criticità
C domicilio	Ampio (quasi come svizzero)	Revoca se dipendenza durevole aiuto sociale (Art. 63 LStrl)
B UE/AELS		

Permesso	Accesso	Criticità
	Assicurazioni contributive	Aiuto sociale influisce sul soggiorno (Art. 62 LStrl)
B Stato terzo	Prestazioni contributive	Maggiore vulnerabilità al rinnovo
F ammesso prov.	Limitato ma esistente	Forte precarietà amministrativa
N richiedente asilo	Solo settore asilo	Diritti ridotti, dipendenza istituzionale
S statuto emergenza	Diritti vantaggiosi vs. N	Temporaneo
Sans-papiers	Molto limitati	Invisibilità, paura segnalazione

Assicurazioni vs. Assistenza

- **Assicurazioni** (lavoro + contributi): uguale accesso svizzeri/stranieri che lavorano
- **Assistenza** (bisogno economico): conseguenze migratorie → **problema principale per gli stranieri**

Problema della non-domanda

- Stranieri rinunciano all'aiuto sociale → paura rinnovo permesso
- Meccanismo: aiuti ricevuti verificati al rinnovo → permesso non rinnovato
- Effetti: indebitamento · rinuncia cure · precarietà abitativa · lavoro in nero
- **"Diritti sociali condizionati" (Borrelli et al., 2021)**
- **Domanda OS: un diritto è davvero accessibile se esercitarlo rischia il soggiorno?**

Sistema sanitario — Spesa crescente

- 1996: 5'292 CHF pro-capite → 2021: 9'924 CHF → +88%; PIL nello stesso periodo: +41%

Fattore di aumento	Meccanismo
Progresso tecnologico	Nuovi farmaci più costosi dei vecchi
Invecchiamento popolazione	Più cure, più case anziani (+26% TI), più domiciliari (+62% TI)
Malattia costi di Baumol	Servizi alla persona non automatizzabili → bassa produttività
Aspettative crescenti	Più ricorso a medici / specialisti

Finanziamento sistema sanitario (2021)

Fonte	%
LAMal	35,8%
Stato (Cantoni + Confederazione + Comuni)	23%
Economie domestiche	22,3%
Altre ass. sociali (infortuni, AI, militare)	9%
Ass. complementare	6,5%
Altro	3,5%

LAMal — Caratteristiche principali

- In vigore: 1996 · Obbligatoria per tutti i residenti
- Casse malati: enti **privati** (~50 oggi)
- Premi NON basati sul reddito → iniqua strutturalmente

- Unica assicurazione sociale svizzera così → tutte le altre hanno contributi proporzionali al salario

Correttivi all'iniquità: - **Sussidi IPT** → 5,5 mld CHF (2020); 28% assicurati; limiti: effetti soglia, differenze cantonali - **Finanziamento pubblico ospedali** → 55% costi stazionari a carico Cantoni via **imposte progressive**

Solidarietà

- **Verticale** → chi guadagna di più paga più imposte → finanzia di più il sistema sanitario
 - **Orizzontale** → sani finanziano malati (LAMal) · lavoratori attivi finanziano pensionati (AVS)
-

Dibattito politico attuale

- 2023: aumento premi +8,7% nazionale / +10,5% Ticino
 - Destra: ↑ franchigia, ↓ copertura LAMal
 - Sinistra: premi ≤ 10% reddito; cassa malati unica pubblica
 - **2026**: proposta franchigia 300→400 CHF (Freidli, UDC)
 - Obiettivo: responsabilità individuale
 - **Critica: penalizza malati cronici; non risolve fattori strutturali di costo**
-

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Carlo De Pietro	Articolo "Finanziare i servizi sanitari" — analisi spesa e iniquità LAMal	2023
Borrelli, Kurt, Achermann, Pfirter	"(Un)Conditional welfare?" — aiuto sociale come controllo migratorio	2021
Samir (regista)		2024

Chi	Cosa	Quando
	Film "La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri"	
Esther Freidli (UDC)	Mozione aumento franchigia LAMal 300→400 CHF	2025
Baumol & Bowen	"Malattia dei costi" nei servizi alla persona	1965

Parole chiave

Überfremdung · inforestierimento · statuto stagionale · libera circolazione · criterio contribuzione · criterio residenza · criterio statuto · non-domanda · diritti sociali condizionati · LAMal · premi non basati sul reddito · sussidi IPT · solidarietà verticale · solidarietà orizzontale · malattia dei costi di Baumol · franchigia · cassa malati unica